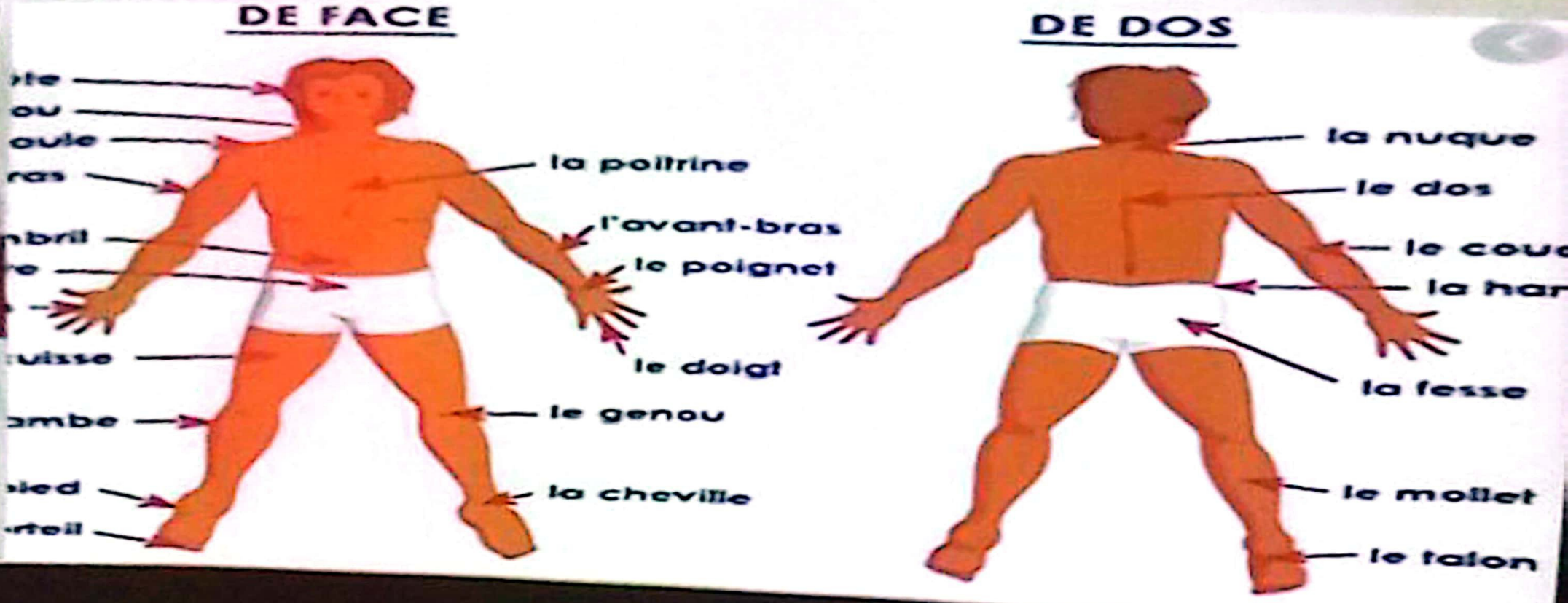
SEMIOLOGIE DE L'APPAREIL LOCO MOTEUR

DR BOUMEDIENE

maître assistante en rhumatologie



Cas clinique :

- Patiente MH ,âgée de 56 ,mariée ,mère de deux enfants qui se plaint d'une douleur au niveau du bas du dos .

faite votre interrogatoire ?

MOTIFS DE CONSULTATIONS :

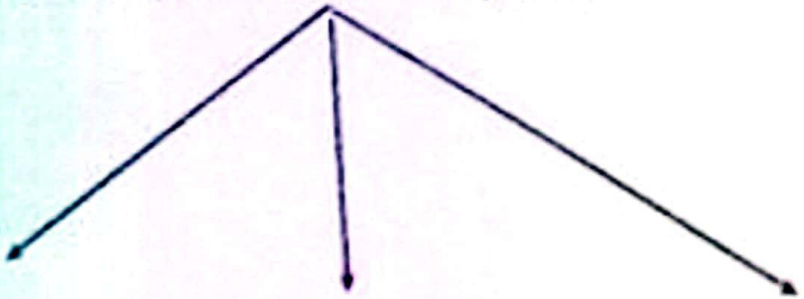
- La douleur : le maitre symptôme de l'appareil loco moteur , c'est le signe cardinal et le motif de consultation le plus fréquent .
- Un gonflement articulaire ou d'un membre
- Une déformation articulaire

- Une impotence fonctionnel d'un membre ,d'une articulation (impossibilité de pratiquer une activité normale)

L'INTERROGATOIRE :

- TEMPS essentiel
- Il doit être minutieux

Il doit répondre à trois questions :



Ou ? Comment? Depuis quand ?

L'interrogatoire va préciser :

- La profession exercée
- Les sports pratiqués en détaillant l'activité physique
- Les traumatismes subis
- Les antécédents rhumatologiques
- Les traitements suivis
- Les antécédents digestifs (UGD)

COMMENT ANALYSE UNE DOULEUR ARTICULAIRE

1/OU ?

- Préciser le siège exacte de la douleur (le patient va la montrer avec son doigt).



2/ comment?

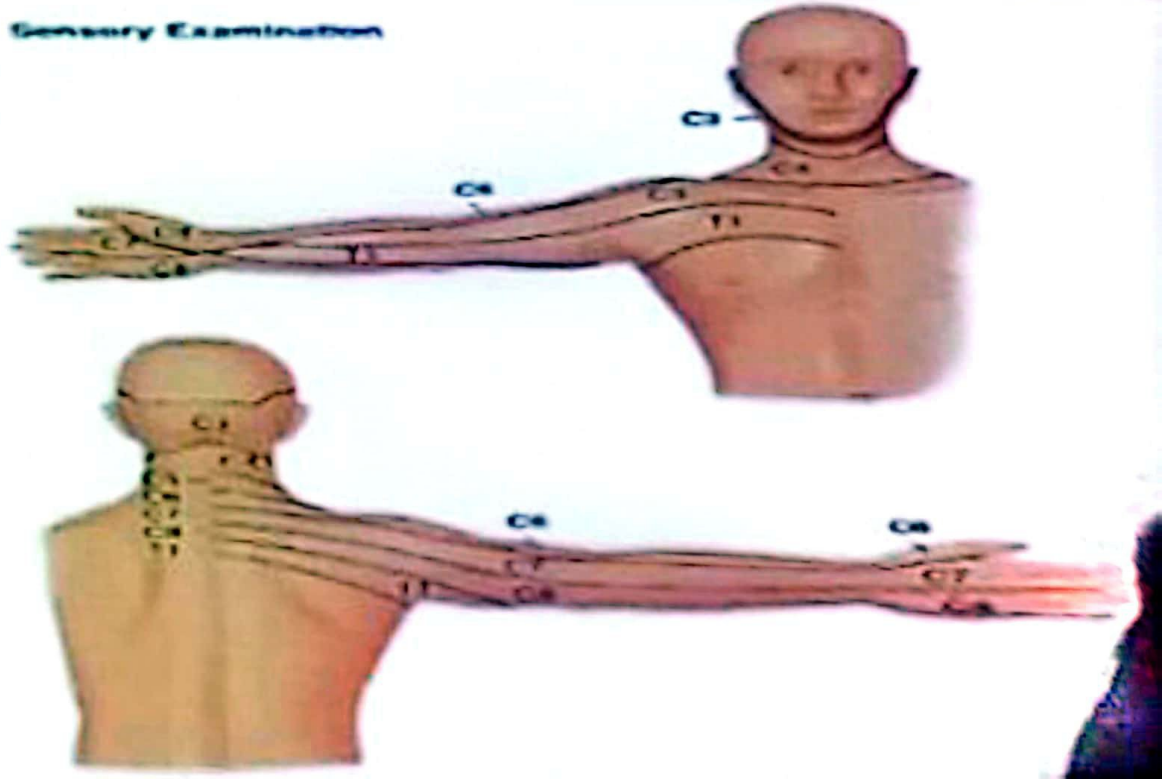
- *Préciser* son horaire : temps primordial de l'interrogatoire
- S'agit-il d'une douleur mécanique ou inflammatoire

La douleur mécanique :
- peu ou absence de dérouillage matinal
- douleur qui apparait après l'effort
- calme par le repos
- réveille nocturne absent

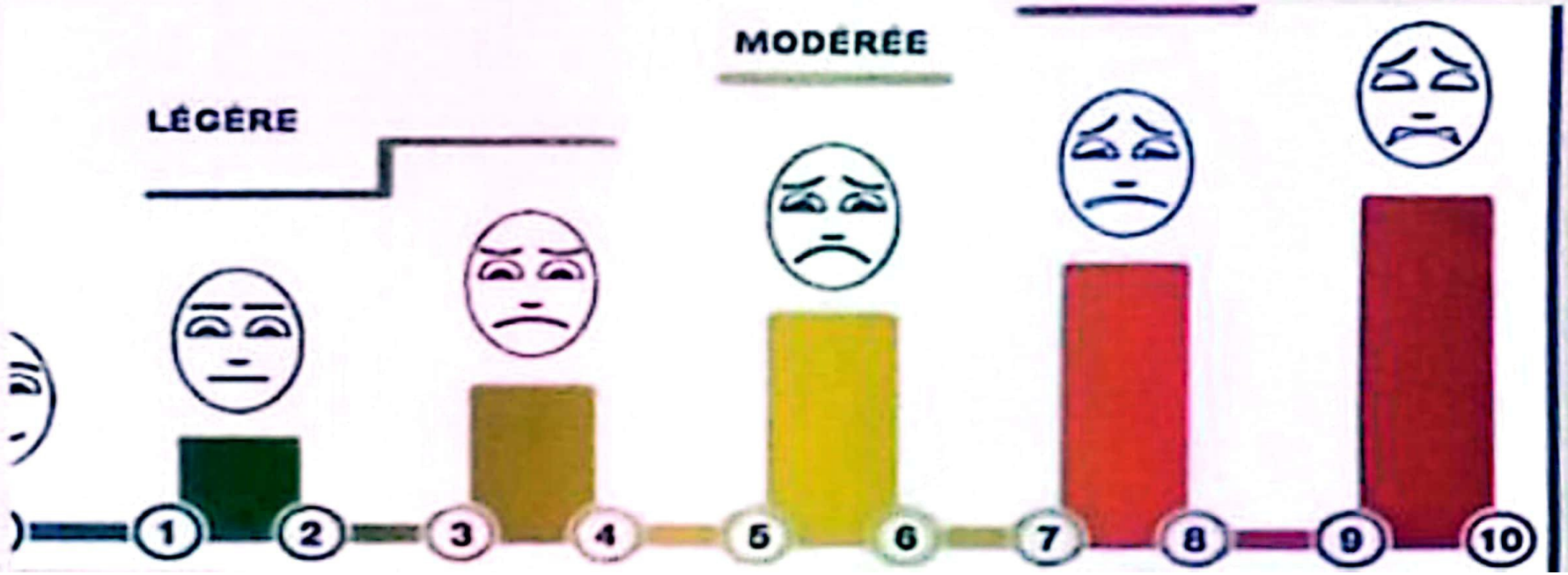
La douleur inflammatoire :
- un dérouillage matinal
- douleur non calme par le repos
- réveillant le malade à la deuxième moitie de la nuit
- non calme par le repos

- La douleur radiculaire : c'est une douleur qui suit le trajet d'une racine nerveuse :
- L5 :son trajet la partie post externe de la cuisse ,la partie externe de la jambe, du dos du pied et se termine au niveau du gros orteil.

- S1 (fesse, jambe, la partie externe ace postérieure de la cuisse et du mollet, talon ou gouttière rétro-malléolaire externe, plante ou bord externe du pied, trois derniers orteils).
- La névralgie cervico –brachiale



- Le type de la douleur : crampes , lourdeurs ,pesanteur ,décharge électrique
- Dépendras de chaque patient
- Son intensité :qui seras calcule par EVA



- Retentissement fonctionnel: sur les activités de la vie quotidienne , sa vie professionnelle .
- Sensibilité de la douleur :ceux sont les facteurs qui modifient la douleur (calme par les AINS).

- **3/depuis quand:**

Douleur aigue : qui évolue depuis moins de 02 mois

Douleur chronique : qui évolue depuis plus de 03 mois

Est-ce que une douleur qui évolue par poussé –rémission

ANTCD personnel et familiaux : SPA,PR, goutte ,chondrocalcinose....., prise médicamenteuse.

LES DIFFERENTS TYPES DE DOULEURS :

- Rachis : *rachialgies*
- Cervicales : cervicalgies
- Dorsales :dorsalgies
- Lombaires : lombalgies
- Sacrum : sacra algies
- Une douleur articulaire : arthralgie
- Epaule : scapulalgie
- Talon : talalgie
- Fesse : fessialgie
- Genou : gonalgie

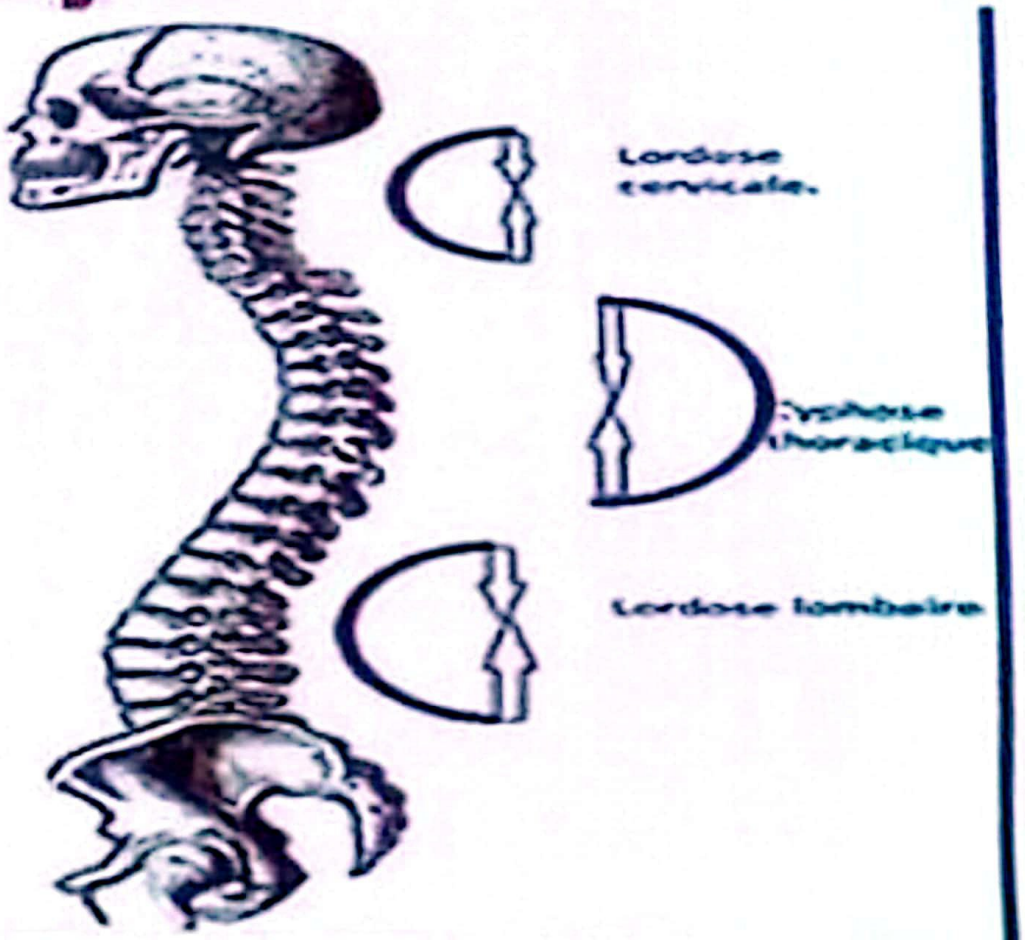


L'examen clinique :

- Méthodique:
- Examen de la marche
- Examen du squelette axial
- Examen des articulations périphériques
- Doit toujours être terminé par un examen somatique complet
- Comparatif avec l'articulation symétrique
- Plusieurs temps : inspection, palpation, mobilité

EXAMEN DU RACHIS:

- Patient déshabille
- Examen statique et dynamique:
- Patient debout en appui symétrique ,Il rechercheras un trouble statique DS le plan frontal(scoliose)et DS le plan sagittal(lordose ,cyphose)
- La marche du patient normal , a petit pas ,s'aidant d'une canne
-



-lordose cervicale

cyphose dorsale

lordose lombaire

- La scoliose est une déformation plus ou moins importante de la colonne vertébrale dans le plan latérale. Elle peut s'accompagner d'une torsion de la colonne vertébrale, d'une déformation du thorax, de l'abdomen et des zones proches du rachis.

La lordose est une courbure anormale, à convexité antérieure de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que les reins sont "creux" et que le ventre est anormalement projeté en avant.

- La cyphose est une courbure anormalement exagérée de la colonne dorsale, à convexité postérieure



Rachis cervical:

- Rachis cervical: segment très mobile
- Rotations: distance menton acromion=0
- Inclinaisons : distance lobe de l'oreille acromion=0
- Flexion: distance menton sternum=0
- Extension :45 °(distance occiput –mur)=0

rachis dorsolombaire

- Le rachis dorsale : c'est un segment peu mobile
- Flexion: -distance doigt sol=0
- manœuvre de Schobert: mesurer 10 cm au dessus de L5 malade débout, puis demander au patient de faire une flexion et remesurer cette distance qui passer de 10cm a14cm .
- Mesurer la distance doigt –sol
- Inclinaisons droite et gauche: le rachis dessine une courbe à concavité latérale et régulière.
- L'extension du rachis: s'explore en demandant au malade de se redresser contre la main de l'examinateur placée sur les lombes.
- Mesure de l'ampliation thoracique (par un mètre ruban la distance du mamelon droit , contourne le thorax arrivée au mamelon gauche)sup 5cm

- Recherche de points douloureux: épineuses, paravertébraux
- Signe de la sonnette: reproduction de la radiculalgie par la pression appuyée de l'espace inter épineux L4 L5 ou L5 S1,
- Signe de Lasègue: patient en décubitus dorsal, genou en extension. L'examinateur élève le membre inférieur à partir du plan du lit, en s'opposant à la flexion du genou. Le test est positif s'il reproduit la sciatalgie L5 ou S1



Signe de Léri : patient en décubitus ventral, genou fléchi à 90°. L'examinateur élève le membre inférieur à partir du plan du lit, en maintenant la hanche ipsilatérale en contact avec la table



Examen des articulations sacro-iliaques:

- Signe du trépied: sur un malade en décubitus ventral, on exerce une forte pression avec les mains à plat sur la région sacrée déclenche la douleur au niveau sacro-iliaque ,

- Signe de Menel : malade place en décubitus latérale une jambe en flexion et l'autre jambe tire vers l'extérieure qui va d'éclanche la douleur de l'articulation ,

- Rapprochement – écartement sur l'articulation des os iliaques,



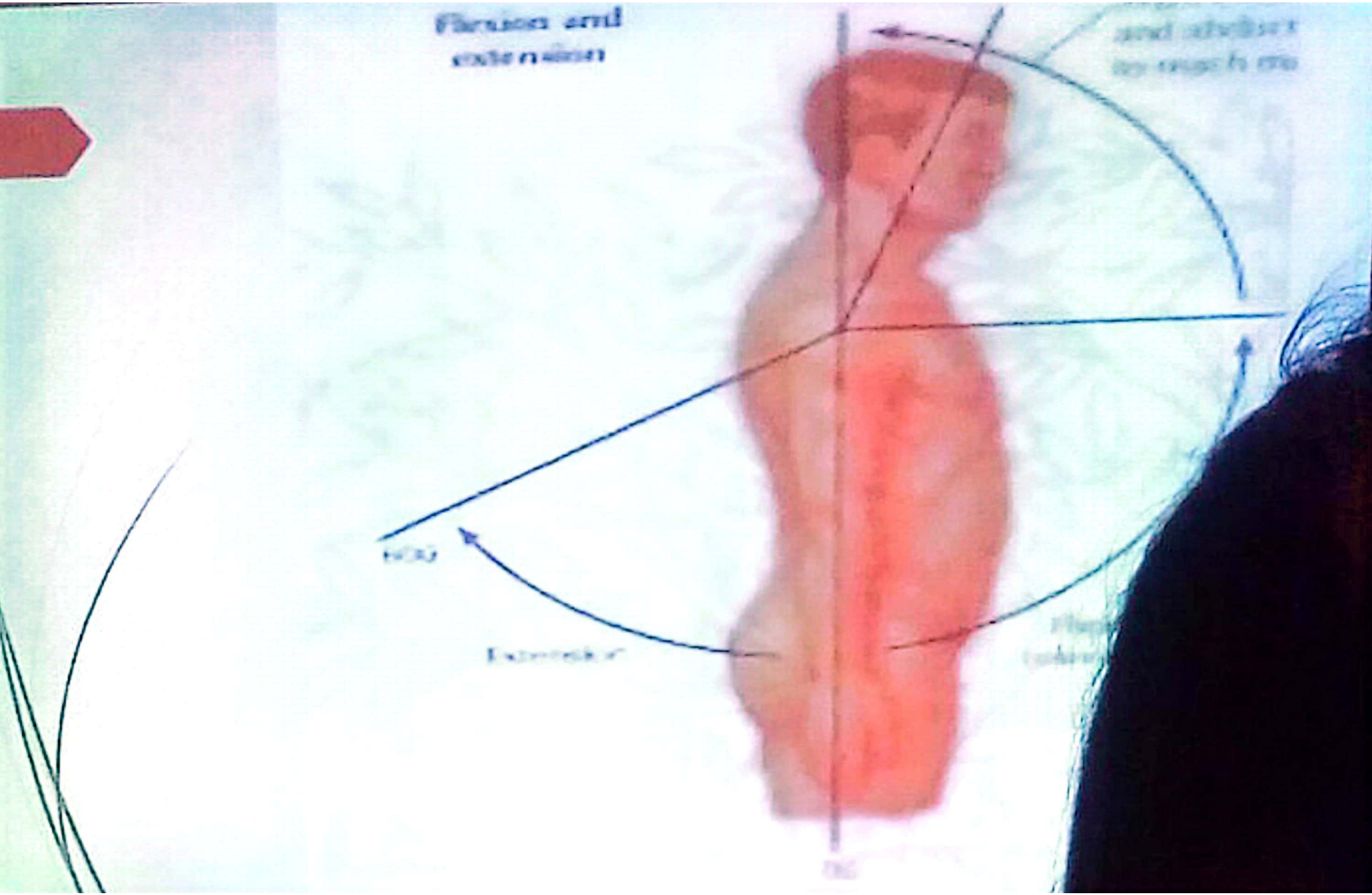


- Etude des mobilités passive et active
- 3 mouvements simples pour établir un diagnostic:
- -élévation antérieure ou flexion:180°
- -rotation interne: 70°
- -rotation externe:60°
- Abduction:180°
- Adduction :gêné par le thorax

3 degrés de liberté:

- flexion-extension (180°/0/ 25°)
- abduction-adduction (180°/0/30°)
- rotation interne-externe: (80°/0/ 60°)

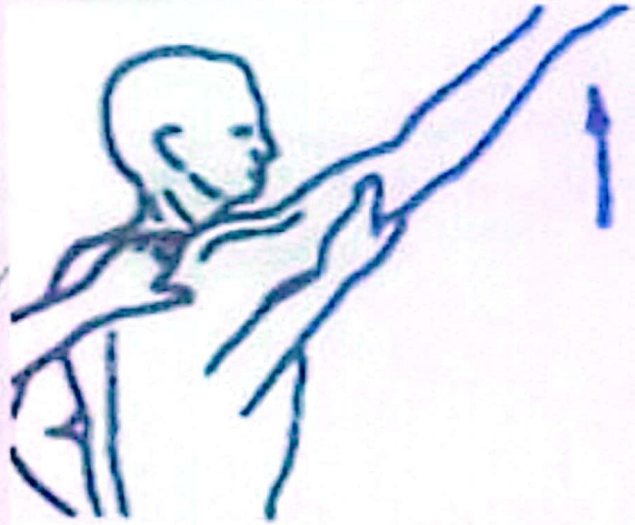



Flexion and
extension


internal rotation

Signe de nier:

- L'élévation antérieure passive de l'épaule, main en pronation, en bloquant la rotation de l'omoplate Positif si douleur entre 60 et 120° Disparaît si main en supination







Neer

Yocum

Schéma : Recherche d'un conflit sous acro
(D'après G. Walch)

Signe de You

- Main du patient sur l'épaule opposée, bras à 90° d'élévation antérieure On demande au patient de lever le coude contre résistance Positif si apparaît la douleur

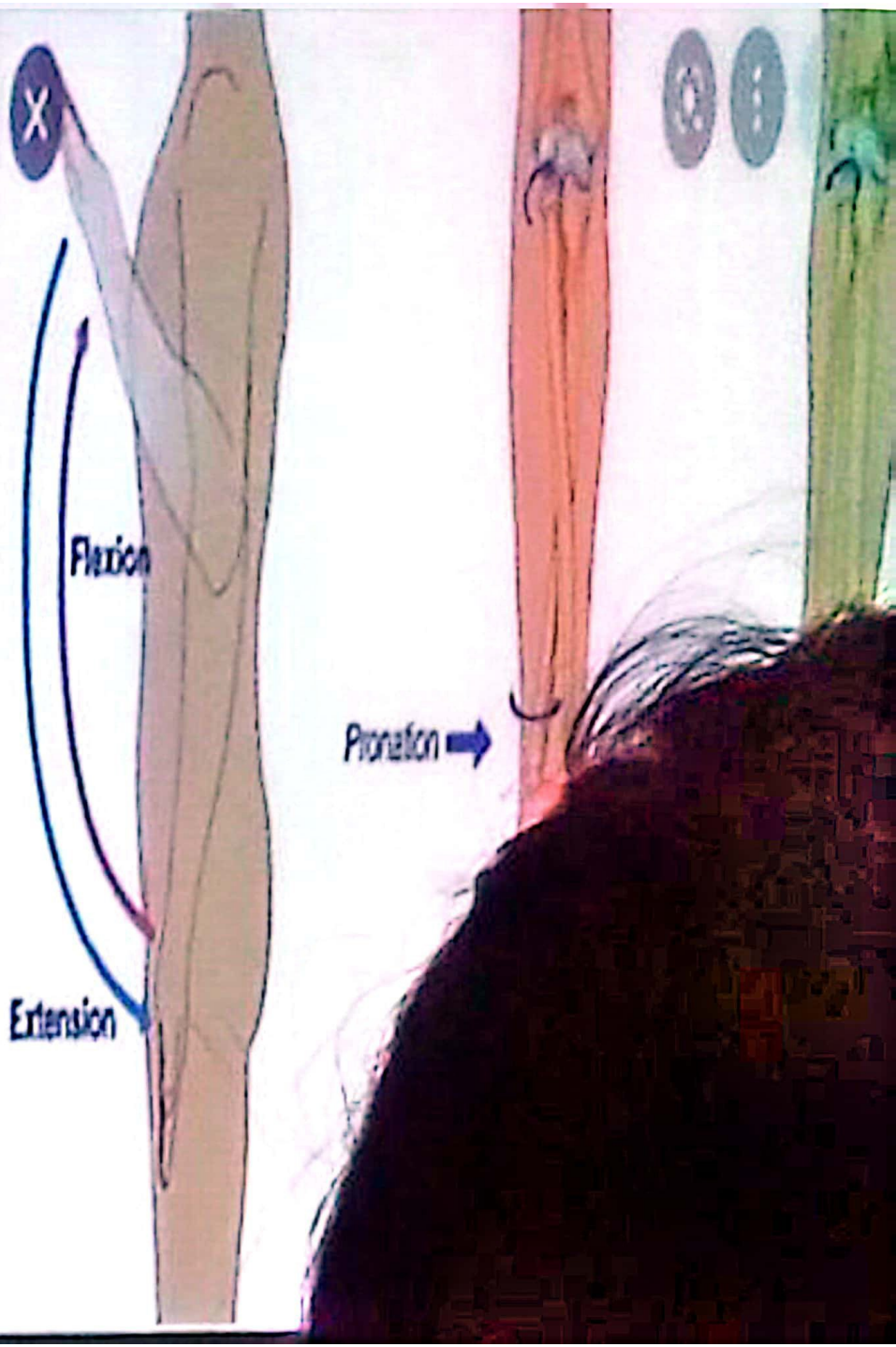


Neer Yocum Hawkins

Schéma : Recherche d'un conflit sous acromial
(D'après G. Walch)

Examen du coude :

- Recherche les reliefs de l'articulation
- L'extension:150°
- La flexion:150°
- Pronation:80°
- Supination: 90°



Hanches :

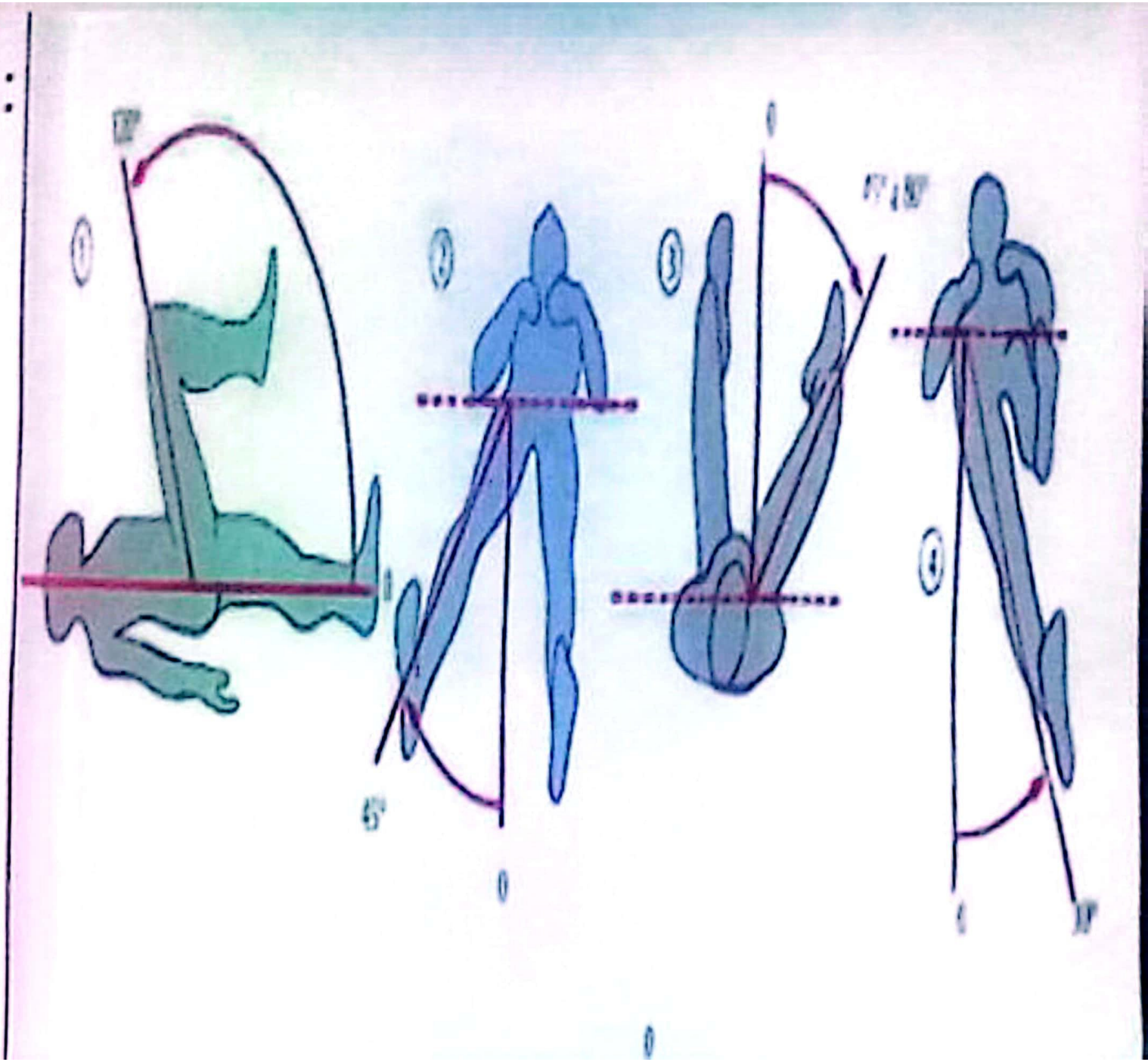
- Flexion=120°
- Extension=10°-15°

Abduction=50°

Adduction=30°- 45°

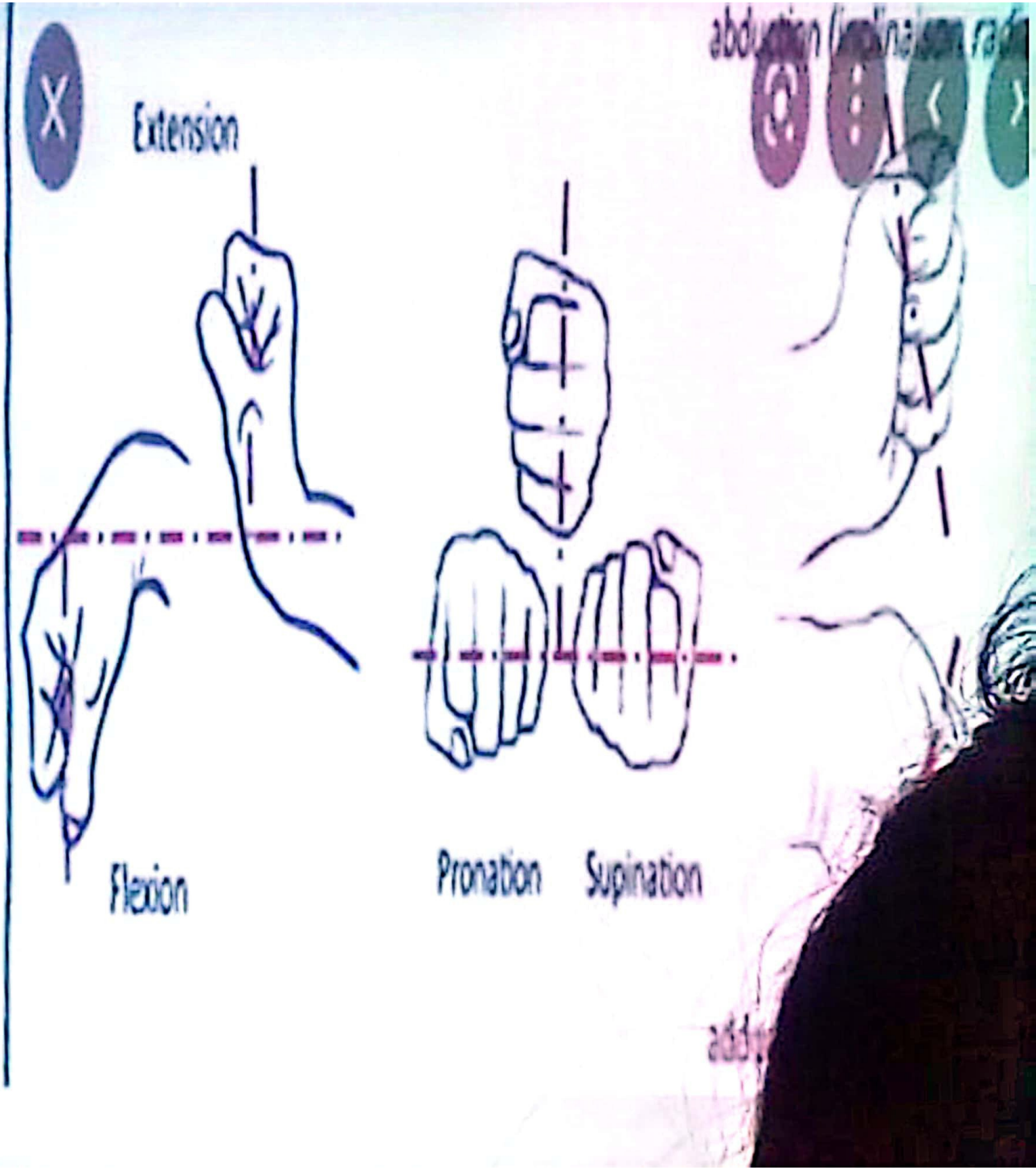
Rotation interne : 45°

Rotation externe: 45°



Poignet-main:

- flexion=75°
- extension= 70° °
- inclinaison radiale= 20°
- inclinaison cubitale= 30°



Genou:

- rticulation superficielle, On a deux *articulations:-fémoraux-tellaire -fémoraux-tibiale*
- L'examen clinique comprend cinq temps:
- 1- le temps statique: malade en garde a vus :
- genu-varum: augmentation de la distance inter condylienne
- genu-valgum: augmentation de la distance inter malléolaire
- genu-recrvatum: un angle antérieur entre cuisse et tibia
- genu-flessum:un angle postérieur entre cuisse et tibia



- A l'examen clinique :

- Un épanchement articulaire : par le signe du choc rotulien
- Signe du rabots
- Une amyotrophie quadricipitale

- L'extension:0°

- La flexion: 120° avec distance talon –fesse 10cm



Cheville –pied :

- Flexion- extension Dorsi flexion =20°
- Flexion plantaire=50°
- Le pied comprend cinq régions fonctionnelles: talon, medio tarse, métatarses, les orteils, la plante

Arthrites :

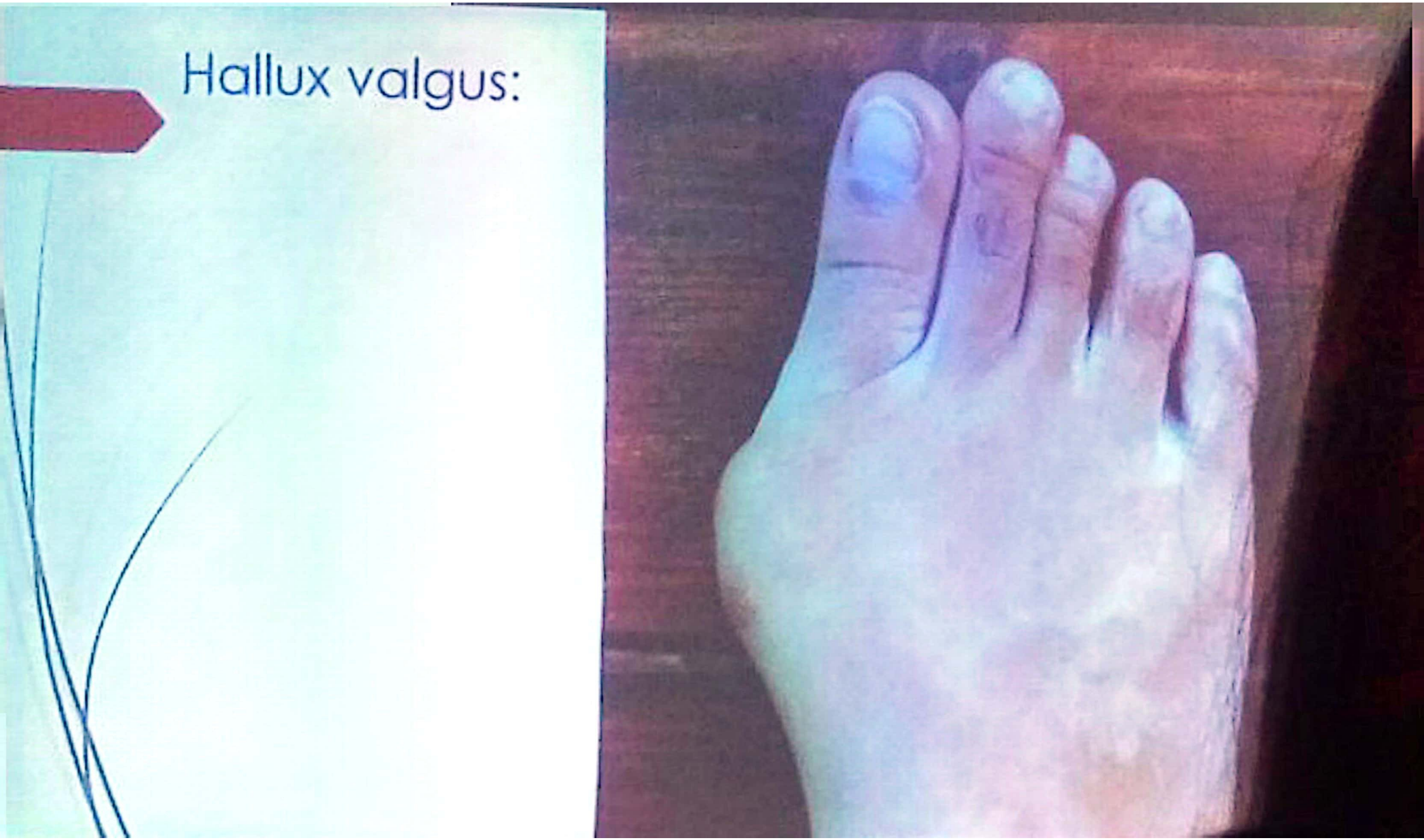
- Un gonflement de l'articulation qui se caractérise par 4 signes :
- Rougeur
- Chaleur
- Douleur
- Un gonflement
- Cette arthrite traduit la présence d'un épanchement articulaire donc il faut pratiquer une ponction évacuatrice pour étude cytobactériologique a vise diagnostic et apprécier l'état du liquide articulaire (jaune citrin)
- selon le nombre des articulations atteintes :
- mono-arthrite: une seule articulation
- Oligo-arthrite: deux ou trois articulations
- polyarthrite: quatre et plus



Les malformations :

- La boiterie :se définie par une démarche anormale.
- Les malformations du rachis
- Les malformations des membres inférieures (genu-varum, genu-valgum....)
- Les déformations retrouvés au cours des fractures ,maladies inflammatoires et maladies dégèratives

Hallux valgus:



Flessum du genou

